

Adjuwant — *nie zamiennik psychoterapii*

Farmakoterapia w C-PTSD jest uzupełnieniem psychoterapii, nie zastąpieniem. ISTSS (2019): psychoterapia jest leczeniem pierwszego rzutu. Leki — drugiego.

CZAS: 10 min — orientacja przed konsultacją psychiatryczną **REALIZACJA:** Faza 1 stabilizacji lub kryzys

ŹRÓDŁO: ISTSS (2019, *Expert Consensus Guidelines*); Hoskins i in. (2015, Cochrane: SSRI $d = 0,23-0,31$); Raskind i in. (2013, RCT prazosyna); Guina i in. (2015, BZD przeciwwskazane); Hoge i in. (2014, mniejsze efekty w C-PTSD)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **co działa**: SSRI (sertralina, paroksetyna), prazosyna na koszmary, ewentualnie inne leki adjuwantowe. W sekcji 02 — **czego unikać**: benzodiazepiny (przeciwwskazane), TLPD (mniej skuteczne). Sekcja 03 — **twoja konsultacja**: pytania do psychiatry. Sekcja 04 — sygnały do natychmiastowego kontaktu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Farmakoterapia w C-PTSD jest **adjuwantowa** — nie zastępuje psychoterapii. ISTSS (2019, *Expert Consensus Guidelines*): psychoterapia jest leczeniem *pierwszego rzutu*, leki *drugiego* (gdy psychoterapia niedostępna, niewystarczająca, lub objawy uniemożliwiają terapię). **Tylko dwa leki** mają rekomendację A dla PTSD (i pośrednio C-PTSD): *sertralina* i *paroksetyna* — jedyne zatwierdzone przez FDA dla PTSD. Hoskins i in. (2015, Cochrane, metaanaliza): SSRI $d = 0,23-0,31$ — *mały* efekt, znacznie mniejszy niż psychoterapia (która ma $d = 0,8-1,2$). **W C-PTSD**: SSRI pomagają na depresję współwystępującą, lęk, drażliwość, intruzje. *Nie* pomagają specyficznie na dysregulację afektu, negatywną koncepcję siebie, trudności relacyjne (domeny DSO) — Hoge i in. (2014): efekty SSRI w C-PTSD są *mniejsze* niż w klasycznym PTSD. **Inne leki**: prazosyna (na koszmary nocne — Raskind i in., 2013, RCT: skuteczna w redukcji koszmarów w PTSD); kwetiapina (mała dawka — sen, drażliwość); stabilizatory nastroju (lamotrygina, walproinian — gdy dysregulacja emocji dominuje, choć ewidencja ograniczona). **Czego unikać**: benzodiazepiny — Guina i in. (2015, przegląd): **nie rekomendowane** w PTSD/C-PTSD. Mogą *pogarszać* przetwarzanie traumy (zaburzają wygaszanie strachu — ang. *fear extinction*), ryzyko uzależnienia, reakcje paradoksalne; *trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne* (TLPD) — mniej skuteczne, więcej działań niepożądanych niż SSRI. **Klinicznie**: klient z C-PTSD od lat na „*koktajlu*”: SSRI + benzodiazepina + neuroleptyk + stabilizator nastroju. Każdy lek dodany w kryzysie, żaden nie odstawiony. Objawy nieleczone, działania niepożądane kumulowane. Benzodiazepiny w PTSD/C-PTSD *pogarszają* rokowanie. Rozwiązanie: farmakoterapia jako *adjuwant* — SSRI na objawy depresyjne i lękowe, prazosyna na koszmary; unikać benzodiazepin; plan farmakologiczny razem z psychiatrą świadomym traumy; cel: wsparcie psychoterapii, nie zastąpienie. **Ważne reguły**: kontynuuj leki podczas psychoterapii (odstawienie w trakcie ekspozycji = gorsze wyniki); zmiana leków zawsze ze specjalistą, *nigdy nagle*.

01 Co działa (rekomendowane)

LEK / GRUPA	WSKAZANIE	CO WARTO WIEDZIEĆ
SSRI — <i>sertralina</i>	Depresja, lęk, intruzje	Rekomendacja A (ISTSS, FDA). Hoskins (2015, Cochrane): $d = 0,23-0,31$ (mały efekt). Pełne działanie po 4-8 tyg.
SSRI — <i>paroksetyna</i>	Depresja, lęk, intruzje	Rekomendacja A. Trudniejsza w odstawianiu (objawy z odstawienia). Często wybierana, gdy sertralina nie działa.
Prazosyna	Koszmary nocne	Raskind (2013, RCT): redukcja koszmarów PTSD. Często niedoceniana. Bierze się wieczorem.

02 ? Czego unikać — i dlaczego

⚠ BENZODIAZEPINY

Guina i in. (2015): *nie rekomendowane w PTSD/C-PTSD. Zaburzają wygaszanie strachu (ang. fear extinction) — pogarszają przetwarzanie traumy. Wysokie ryzyko uzależnienia. Reakcje paradoksalne (dezyhibicja, agresja). Doraźne stosowanie wyjątkowe.*

⚠ TLPD I NADMIERNA POLIPRAGMAZJA

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne: mniej skuteczne, więcej działań niepożądanych niż SSRI.
Polipragmazja (3+ leki psychotropowe): w C-PTSD często „koktajl” gromadzony w kryzysach — każdy lek dodany, żaden odstawiony. Wymaga rewizji z psychiatrą.

03 ✎ Moja konsultacja psychiatryczna

CO OBECNIE BIORĘ

— wszystkie leki psychotropowe: nazwa, dawka, od kiedy, na co; również suplementy i preparaty bez recepty

MÓJ GŁÓWNY CEL FARMAKOTERAPII

— sen / lęk / depresja / koszmary / drażliwość; jeden cel jest skuteczniejszy niż „wszystko”

PYTANIA DO PSYCHIATRY

— „czy biorę benzodiazepiny?”, „czy plan obejmuje stopniowe odstawianie?”, „czy znasz specyfikę C-PTSD vs klasyczne PTSD?”, „czy współpracujesz z moim psychoterapeutą?”

SYGNAŁY DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU

— pogorszenie objawów, myśli suicydalne, działania niepożądane (wysypka, gorączka, zaburzenia rytmu serca)

Klucz: farmakoterapia w C-PTSD ma *mniej* skuteczność niż w klasycznym PTSD (Hoge i in., 2014) — bo SSRI nie adresują domen DSO (dysregulacja afektu, negatywne self, trudności relacyjne), które są *centralne* w C-PTSD. To *nie* znaczy, że leki są bezużyteczne — pomagają na współwystępującą depresję, lęk, koszmary. Ale *nie* są „leczeniem” C-PTSD. ISTSS (2019) jednoznacznie: psychoterapia pierwsza, leki drugie. Najgroźniejszy mit: „*najpierw ustabilizujemy farmakologicznie, potem terapia*” — w C-PTSD prowadzi to do lat „*stabilizacji*” bez psychoterapii, kumulacji leków, polipragmazji. Skuteczny model: *równoległe* — psychiatra + psychoterapeuta + komunikacja między nimi. Pytanie kontrolne do psychiatry: „*czy współpracujesz z moim psychoterapeutą?*” — psychiatra, który nie chce — często nie jest pierwszym wyborem dla pacjenta z C-PTSD.

⚠ *Nigdy nie odstawiaj leków sam/-a, zwłaszcza SSRI (objawy z odstawienia: zawroty głowy, „brain zaps”, lęk, drażliwość) i benzodiazepin (objawy z odstawienia mogą być niebezpieczne, w tym napady drgawkowe). Plan odstawiania zawsze ze specjalistą. Jeśli twój obecny psychiatra przepisuje benzodiazepiny długoterminowo w C-PTSD — warto skonsultować się z drugim specjalistą.*